

Pięć schematów

Wzorce z dzieciństwa w domu z uzależnieniem powtarzają się w dorosłych relacjach jakby były charakterem. Terapia schematów pokazuje, że to nie charakter — to mapa, którą można przepracować.

CZAS: 20 min Wprowadzenie do pracy terapeutycznej

ŹRÓDŁO: Young i wsp. (2003); Brotchie i wsp. (2004); Bowlby (1969)

JAK UŻYWAĆ

Sekcja 01 — **pięć schematów** najczęstszych u DDA, z opisem mechanizmu. Sekcja 02 — **styl przywiązania** i tendencja do powtarzania wzorca. Sekcja 03 — **trzy techniki terapii schematów**, które realnie zmieniają wzorzec. Sekcja 04 — Twoje schematy i pierwszy krok. Pełna praca prowadzona z przeszkolonym terapeutą.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Terapia schematów Younga (1990, 2003) integruje CBT, teorię przywiązania (Bowlby) i podejście doświadczeniowe. Centralny pomysł: doświadczenia z dzieciństwa tworzą **wczesne nieadaptacyjne schematy** — głębokie wzorce, które aktywują się w dorosłości i wpływają na wybory partnerów, reakcje w konfliktach, samoocenę. Brotchie i wsp. (2004): osoby z rodzin z uzależnieniem mają **istotnie wyższe** wyniki w pięciu schematach — nieufność, poświęcanie, podporządkowanie, deprywacja emocjonalna, defektywność. Tendencja do powtarzania (wybór partnera uzależnionego, niedostępnego) nie jest „cechą” — jest **aktywacją schematu**, którą można rozpoznać i zmienić.

01 Pięć schematów najczęstszych u DDA

1 · NIEUFNOŚĆ / KRZYWDZENIE

„Bliscy mnie skrzywdzą”. Rodzic wielokrotnie obiecywał i nie dotrzymywał. Bliskość = ryzyko zranienia. W dorosłości: trudność z zaufaniem nawet osobom godnym zaufania.

2 · POŚWIĘCANIE

„Muszę dbać o innych kosztem siebie”. Parentyfikacja przeniesiona do dorosłości — własne potrzeby na ostatnim miejscu. Często wybierany jako „cecha charakteru”.

3 · PODPORZĄDKOWANIE

„Muszę robić, co inni chcą, bo inaczej mnie porzucą”. Trudność z odmową, z mówieniem o potrzebach, z konfliktem. Każda granica = lęk utraty więzi.

4 · DEPRYWACJA EMOCJONALNA

„Nikt nie zaspokoi moich potrzeb”. Rodzic — fizycznie obecny, emocjonalnie niedostępny. W dorosłości: niezdolność prośby o wsparcie, uprzedzenie, że i tak nikt nie pomoże.

5 · DEFEKTYWNOŚĆ / WSTYD

„Jestem uszkodzony/-a — bo wychowałem/-am się w **takiej** rodzinie”. Wstyd przed innymi, ukrywanie pochodzenia. Najbardziej bolesny — często niewypowiadany, działający spod świadomości.

02 Przywiązanie i tendencja do powtarzania

U DDA dominuje zwykle **lękowo-unikowy** styl przywiązania: silna potrzeba bliskości + silny lęk przed jej kosztami. Z tego wynika klasyczna tendencja — wybór partnerów **emocjonalnie niedostępnych**, kontrolujących lub uzależnionych. Mechanizm: znajomość daje pozorne bezpieczeństwo, a sam wzorzec potwierdza schemat („widać, że nie da się ufać”, „znowu sama dbam o wszystko”).

Łańcuch powtarzania: schemat (np. nieufność) → coping (np. nadkontrola lub unikanie bliskości) → wybór „bezpiecznego” partnera (emocjonalnie niedostępnego, więc mało ryzykownego) → kolejne

komunikowanie schematu i tak nie daje się zbudować bliskości. Praca terapeutyczna polega na rozpoznaniu łańcucha i wprowadzeniu zmiany w jednym z jego punktów — najczęściej najpierw w coping.

03 Trzy techniki terapii schematów, które działają

PRZEPISYWANIE WYOBRAŻEŃ

ang. imagery rescripting

Wracasz w wyobraźni do konkretnej sceny z dzieciństwa. **Wchodzisz** tam jako dorosły/-a i robisz to, czego dziecko wtedy potrzebowało: chronisz, walidujesz, zabierasz. Zmienia emocjonalne znaczenie pamięci.

PRACA Z KRZESŁAMI

dialog trybów

Dialog między Zranionym Dzieckiem (lęk, ból), Wymagającym Rodzicem (krytyka, wstyd) a Zdrowym Dorosłym (ochrona, perspektywa). Wzmacnia głos Zdrowego Dorosłego — który zwykle jest cichszy niż inne.

LIMITED REPARENTING

ograniczone rodzicielstwo

Relacja terapeutyczna jako bezpieczna baza w nazwanych granicach. Doświadczenie stałego, ciepłego, przewidywalnego dorosłego — często pierwszy raz w życiu. Najsilniejsza dźwignia zmiany przywiązania.

04 Moje schematy — pierwsze rozeznanie

NAJSILNIEJSZY SCHEMAT

— który z pięciu najbardziej do mnie pasuje

KIEDY PO RAZ PIERWSZY POJAWIŁO SIĘ TO PRZEKONANIE

— najwcześniejsza pamiętka

JAK TEN SCHEMAT POKAZUJE SIĘ W MOICH OBECNYCH RELACJACH

— konkretny przykład z ostatnich tygodni

CO ZDROWY DOROSŁY WE MNIE POWIEDZIAŁBY O TYM SCHEMACIE

TERAPEUTA LUB PROGRAM

— terapia schematów lub pokrewna, kontakt

Klucz: Najczęstsza pułapka u DDA w terapii: *schemat poświęcania jest niewidoczny dla pacjenta*, bo wygląda jak charakter. „Zawsze dbam o innych — taka po prostu jestem”. Schematy nie czują się jak schematy — czują się jak *ja*. Terapia schematów pokazuje, że *to nie charakter* — to wzorzec wyniesiony z dzieciństwa, którego można się odzwyczaić. Young i wsp. (2003): „Schematy są tak blisko tożsamości, że ich rozpoznanie jest pierwszym, najtrudniejszym i jednocześnie najbardziej wyzwalającym krokiem terapii.”